



Delirium: Estado Confusional Agudo

Reconhecer, prevenir e tratar a emergência cognitiva mais subdiagnosticada

Dr. Igor Cruz Morais

Saúde do Idoso · FCMMG | RQE Geriatria 66254

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Definir delirium (DSM-5) e reconhecer seus subtipos motores;
- Aplicar a CAM e o 4AT para diagnóstico à beira do leito;
- Explicar o modelo de vulnerabilidade × fatores precipitantes;
- Implementar a prevenção multicomponente (HELP) — a intervenção mais eficaz;
- Tratar a causa e manejar com segurança, evitando o uso rotineiro de antipsicóticos.

PARTE 1

O que é o delirium

CASO CLÍNICO — abertura

Sra. Lúcia, 82 anos, 2º dia de pós-operatório de fratura de fêmur.

A equipe a descreve como '**quietinha e sonolenta**'; não come e não interage. Sem agitação.

Ninguém testou a atenção. Está usando opioide e com sonda vesical.

O delirium hipoativo é o mais comum no idoso — e o mais perdido por parecer 'calmo'.

CASO CLÍNICO — a pergunta

'Quietinha' não é o mesmo que 'bem'.

Como confirmar delirium à beira do leito e o que procurar como causa?

Guarde sua resposta — voltaremos a ela no fim.

Delirium — definição (DSM-5)

- **Distúrbio AGUDO de atenção e consciência (a marca registrada)**
- **Instala-se em horas a dias e FLUTUA ao longo do dia**
- **Alteração cognitiva adicional (memória, orientação, linguagem, percepção)**
- **Consequência de condição médica, intoxicação, abstinência ou fármacos**

Comum, grave e caro

20–30%

dos idosos internados (até
50%+ no pós-op/UTI)

ref. 3,7

↑ morte

e maior risco de demência
depois

ref. 11

prevenível

~30–40% dos casos com
prevenção

ref. 4

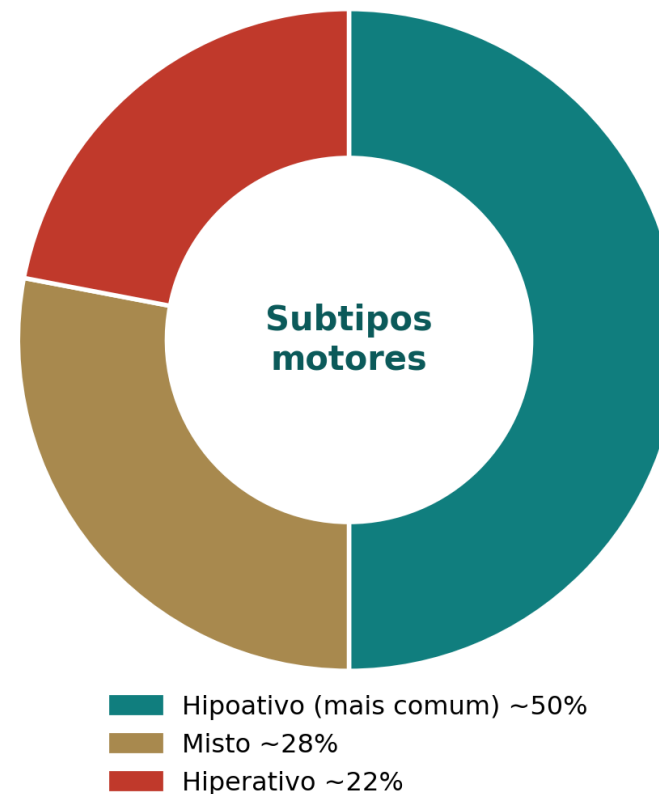
Delirium não é 'da idade': é sinal de doença aguda e marcador de mau prognóstico.

Os subtipos motores

O hipoativo é o mais comum — e o mais subdiagnosticado.

Hipoativo (sonolência, apatia) tem PIOR prognóstico que o hiperativo justamente por passar despercebido.

ref. 3



Onde o delirium mais aparece



Pós-operatório e terapia intensiva concentram os maiores riscos.

Wikimedia Commons · Ad Meskens · CC BY-SA 4.0

- Ambiente, sedação e gravidade somam fatores
- Monitorar com CAM-ICU é rotina
- Prevenção começa no planejamento do cuidado

Por que o delirium importa

- **Aumenta mortalidade hospitalar e em longo prazo**
- **Eleva risco de demência e de declínio funcional persistente**
- **Prolonga internação, quedas e institucionalização**
- **Sufrimento para paciente, família e equipe**

PARTE 2

Reconhecer à beira do leito

CAM — Confusion Assessment Method

1. Início agudo E curso flutuante

2. Inatenção (ex.: meses do ano de trás para frente)

3. Pensamento desorganizado

4. Alteração do nível de consciência

Delirium =

1 E 2

E (3 OU 4)

Sens. ~94% / espec. ~89%

4AT — rápido (< 2 min), não precisa treinamento

- **Alerta (nível de consciência)**
- AMT4: idade, data de nascimento, local, ano
- Atenção: meses do ano em ordem inversa
- Mudança aguda ou curso flutuante

A regra de ouro do reconhecimento

- **TESTE A ATENÇÃO de todo idoso internado com mudança do estado mental**
- **Compare com o basal: pergunte à família como ele 'era' ontem/semana passada**
- **Não confunda hipoativo com depressão ou 'cansaço'**
- **Delirium pode coexistir com demência (delirium sobreposto)**

QUIZ 1 — pause e pense

Idoso internado, sonolento, desatento, com piora que vai e volta no mesmo dia. Sem agitação. É delirium?

Sim — provável delirium hipoativo. Início agudo + inatenção + flutuação fecham CAM, mesmo sem agitação. É o subtipo mais comum e o mais perigoso por passar batido.

PARTE 3

Por que acontece

Modelo de vulnerabilidade × precipitantes

- Quanto mais vulnerável o cérebro, menor o 'gatilho' necessário
- Idoso frágil/demente: até uma ITU ou um sedativo desencadeia
- Jovem hígido: precisa de insulto grave (sepse, grande cirurgia)
- Por isso a prevenção age nos dois lados da balança

Fatores: predisponentes × precipitantes

Predisponentes (basal)

Idade avançada, demência/CCL prévios

Déficit sensorial (visão/audição)

Fragilidade, multimorbidade, polifarmácia

Precipitantes (agudos)

Infecção, dor, distúrbio
metabólico/hidroeletrolítico

Fármacos, cirurgia, retenção urinária/constipação

Privação de sono, contenção, internação em UTI

[Diretriz] Atuar nos precipitantes modificáveis é o cerne da prevenção. ref. 3,6

Fármacos que precipitam (Beers 2023)

- **Anticolinérgicos (muitos! revisar a lista completa)**
- **Benzodiazepínicos e hipnóticos Z**
- **Opioides (necessários às vezes — equilibre com a dor)**
- **Revisar e desprescrever é prevenção ativa de delirium**

PARTE 4

Prevenir é a melhor conduta

HELP — prevenção multicomponente (1ª linha)

- **Reorientação e estimulação cognitiva diária**
- **Mobilização precoce; evitar contenções e sondas desnecessárias**
- Sono protegido (rotina noturna, menos ruído/luz)
- Óculos e aparelhos auditivos; hidratação e nutrição
- **Reduz a incidência em ~30–40%**

Na UTI: pacote ABCDEF

- **Avaliar/tratar dor; despertar e respiração espontânea diários**
- Escolha de sedação (evitar benzodiazepínicos)
- Monitorar delirium (CAM-ICU), mobilização precoce, envolver a família

PARTE 5

Tratar

Passo 1 — encontrar e tratar a causa

- **Mnemônico: infecção, fármacos, metabólico, hipóxia, dor, retenção, abstinência**
- **Reavaliar TODA a prescrição; suspender o que for desnecessário**
- **Corrigir desidratação, distúrbios eletrolíticos, glicemia, constipação**
- **Tratar a causa É tratar o delirium**

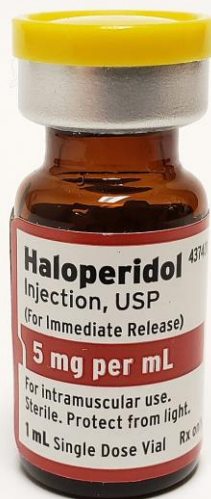
Passo 2 — manejo não-farmacológico

- **Reorientar, aproximar a família, restaurar óculos/aparelho auditivo**
- Mobilizar, proteger o sono, ambiente calmo e iluminação adequada
- **Evitar contenção física (piora a agitação e o desfecho)**

Passo 3 — fármacos: exceção, não regra

- **Antipsicóticos NÃO previnem nem encurtam o delirium**
- **Reservar a sofrimento/agitação grave com risco a si ou a terceiros**
- **Se preciso: haloperidol em dose baixa OU atípico; monitorar QTc e EPS**
- **Benzodiazepínico só na abstinência de álcool/BZD; senão, piora**

Quando o haloperidol entra (e quando não)



- Não previne nem encurta o delirium
- Monitorar QTc e sintomas extrapiramidais
- Evitar na DLB/Parkinson; preferir atípico se preciso

Haloperidol: apenas para agitação grave com risco — dose baixa, tempo curto.

Wikimedia Commons · M. Oniffrey · CC BY-SA 4.0

Fluxo de manejo do delirium

1. Confirmar (CAM/4AT) e garantir segurança

2. Buscar e tratar a causa (infecção, fármacos, metabólico)

3. Medidas não-farmacológicas + prevenção contínua

4. Fármaco só se agitação grave/risco — dose mínima

Lembre:

antipsicótico não trata a causa;
evitar contenção e BZD;
reavaliar sempre.

QUIZ 2 — de volta à Sra. Lúcia

Pós-op de fêmur, hipoativa, em opioide e com sonda. Conduta?

Causa → não-farma → (raramente) fármaco. Confirme com CAM; revise opioide, retire a sonda se possível, trate dor/constipação, descarte ITU; reoriente e mobilize. Antipsicótico só se agitação grave — não para 'a sonolência'.

PARTE 6

Para levar

Mensagens para levar para casa

- ✓ Delirium = início agudo + inatenção + curso flutuante. Teste a atenção!
- ✓ O hipoativo é o mais comum e o mais perigoso — não o confunda com 'estar calmo'.
- ✓ Use CAM/4AT e sempre compare com o estado basal (ouça a família).
- ✓ A prevenção multicomponente (HELP) é a intervenção mais eficaz — ~30–40% menos casos.
- ✓ Trate a causa; antipsicóticos são exceção; evite benzodiazepínicos e contenção.

“Medicine is a science of uncertainty and an art of probability.”

— William Osler

Referências (Vancouver)

1. Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, et al. Clarifying confusion: the Confusion Assessment Method (CAM). Ann Intern Med. 1990;113(12):941-8.
2. Bellelli G, Morandi A, Davis DHJ, et al. Validation of the 4AT for delirium detection; meta-analysis. Age Ageing. 2014/2021.
3. Inouye SK, Westendorp RGJ, Saczynski JS. Delirium in elderly people. Lancet. 2014;383(9920):911-22.
4. Inouye SK, Bogardus ST, Charpentier PA, et al. A multicomponent intervention to prevent delirium in hospitalized older patients (HELP). N Engl J Med. 1999;340(9):669-76.
5. By the 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. AGS 2023 updated Beers Criteria. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-81.
6. American Geriatrics Society Expert Panel. Clinical practice guideline for postoperative delirium in older adults. J Am Geriatr Soc. 2015;63(1):142-50.

Referências (Vancouver)

7. Marcantonio ER. Delirium in hospitalized older adults. N Engl J Med. 2017;377(15):1456-66.
8. American Psychiatric Association. DSM-5: Delirium. Arlington: APA; 2013.
9. Girard TD, Exline MC, Carson SS, et al. Haloperidol and ziprasidone for treatment of delirium in critical illness (MIND-USA). N Engl J Med. 2018;379(26):2506-16.
10. Witlox J, Eurelings LSM, de Jonghe JFM, et al. Delirium in elderly patients and risk of post-discharge mortality, institutionalization and dementia: meta-analysis. JAMA. 2010;304(4):443-51.
11. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Delirium: prevention, diagnosis and management (CG103). London: NICE; updated 2023.
12. Ministério da Saúde (Brasil) / SBGG. Cuidado à pessoa idosa: síndromes geriátricas. Brasília; 2023-2024.



Obrigado.

Dr. Igor Cruz Morais

Cardiologia · Geriatria · Medicina Intensiva — CRM-MG 76695

Saúde do Idoso · FCMMG

igor.morais@rpt.org.br · WhatsApp (31) 9 9735-4136 · Instagram @igormorais1